

TEMA 2.12 • GINECOLOGÍA

Algias Pélvicas Agudas (APA)

PERFIL EUNACOM 2.01.1.077

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Algias Pélvicas Agudas (APA)

Causas Principales

TABLA 2.12.1: TIPO VS CAUSAS

TIPO	CAUSAS
Ginecológicas	Ovulación dolorosa, cuerpo lúteo hemorrágico, degeneración roja de mioma, torsión ovárica , PIP
Obstétricas	Aborto (amenaza o en curso), embarazo ectópico roto , corioamnionitis
Digestivas	Apendicitis, diverticulitis, absceso perirrectal
Urinarias	Cólico renal, cistitis

Enfrentamiento General

- Anamnesis + examen físico completo
- βHCG siempre en mujer en edad fértil** (descartar causa obstétrica — omitirlo es responsabilidad médico-legal)
- Evaluación ginecológica (descartar causa ginecológica)
- Ecografía transvaginal** (examen de elección)
- Tratamiento según causa

Causas Ginecológicas Específicas

Ovulación Dolorosa (Mittelschmerz)

- **Día de la ovulación** (día del ciclo – 14 días) - Buen estado general; puede haber leve signo de Bloomberg - Diagnóstico: ETV → folículo roto + escaso líquido libre (normal) - **Diferencial:** Apendicitis (cuando es del lado derecho) - **Tratamiento:** AINEs (autolimitada)

Cuerpo Lúteo Hemorrágico

- **Fase lútea** (después del día de ovulación) - Clínica igual a ovulación dolorosa - Diferencia con ovulación dolorosa: el día del ciclo en que ocurre - ETV: tumor heterogéneo (cuerpo lúteo aumentado) - **Tratamiento:** AINEs

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Clave diferencial: revisar la FUR y calcular el día del ciclo. Antes del día 14 → ovulación dolorosa. Después del día 14 → cuerpo lúteo hemorrágico.

Degeneración Roja de Mioma

- Mioma que se infarta (infarto hemorrágico) - Clínica: antecedente de mioma + dolor pélvico intenso - **Frecuente durante el embarazo** (mayor riesgo de infartarse) - ETV: mioma con aspecto heterogéneo/irregular - **Tratamiento:** AINEs (observación durante embarazo — cirugía contraindicada en gestante)

Miomas en el embarazo:

- 1/3 aumenta de tamaño

- 1/3 se mantiene igual
- 1/3 disminuye
- Complicaciones: degeneración roja, aborto, parto prematuro

Torsión Ovárica

Factor de riesgo más importante: Tumor ovárico > 5–10 cm (especialmente teratoma).

Clínica:

- Dolor pélvico intenso + síntomas neurovegetativos (sudoración, náuseas, vómitos)
- Puede irradiar a zona genital y lumbar (similar a torsión testicular)
- No suele pasar la línea media

Diagnóstico: ETV con Doppler → ovario aumentado + sin flujo vascular.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante la mera sospecha clínica, operar. Si la sospecha clínica es alta, el tratamiento no espera resultados del Doppler (que puede ser falso negativo). Igual que en la torsión testicular.

Tratamiento: Destorsión quirúrgica por laparoscopia de urgencia.

PIP (Proceso Inflamatorio Pélvico)

- Triada: **Fiebre + Leucorrea + Dolor pélvico** - ETV: puede mostrar absceso tubo-ovárico (ATO) - Tratamiento: ATB amplio espectro; si ATO → drenaje quirúrgico por laparoscopia - Ver clase específica de PIP

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 27 años, con DIU, consulta por dolor pélvico agudo de 6 horas de evolución, fiebre 38.4°C y flujo vaginal purulento. Al examen: dolor a la movilización cervical y anexos bilateralmente sensibles. β-hCG negativa. Leucocitosis 14.000/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento de primera línea?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Algias Pélvicas Agudas (APA). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Causas Principales
- Enfrentamiento General
- Causas Ginecológicas Específicas
- Ovulación Dolorosa (Mittelschmerz)
- Cuerpo Lúteo Hemorrágico
- Degeneración Roja de Mioma
- Torsión Ovárica

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ALGIAS PÉLVICAS AGUDAS (APA))

PREGUNTA 1

Mujer de 27 años, con DIU, consulta por dolor pélvico agudo de 6 horas de evolución, fiebre 38.4°C y flujo vaginal purulento. Al examen: dolor a la movilización cervical y anexos bilateralmente sensibles. β -hCG negativa. Leucocitosis 14.000/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento de primera línea?

- A) Apendicitis aguda — laparotomía de urgencia
- B) Embarazo ectópico complicado — laparotomía
- C) Proceso inflamatorio pélvico (PIP) — ceftriaxona + doxiciclina + metronidazol
- D) Quiste ovárico complicado — analgesia y observación
- E) Torsión ovárica — cirugía laparoscópica urgente

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Algias Pélvicas Agudas (APA)?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Algias Pélvicas Agudas (APA). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: ALGIAS PÉLVICAS AGUDAS (APA)

1. Anamnesis + examen físico completo 2. β HCG siempre en mujer en edad fértil (descartar causa obstétrica — omitirlo es responsabilidad médico-legal) 3. Evaluación ginecológica (descartar causa ginecológica) 4. Ecografía transvaginal (examen de elección) 5. Tratamiento según causa ::::tip Clave diferencial: revisar la FUR y calcular el día del ciclo. Antes del día 14 → ovulación dolorosa. Después del día 14 → cuerpo lúteo hemorrágico. ::::warning Ante la mera sospecha clínica, operar. Si la sospecha clínica es alta, el tratamiento no espera resultados del Doppler (que puede ser falso negativo). Igual que en la torsión testicular. ::::